Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
3ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

ROD BR-101 SUL KM 80, S/N, - do km 86,007 ao km 88,000, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54345-160 - F:(81) 34615600

Processo nº **0022491-59.2023.8.17.2810**

AUTOR(A): SEVERINO RAMOS GUEDES JUNIOR

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

SEVERINO RAMOS GUEDES JUNIOR, parte autora qualificada nos autos, por intermédio de advogado legalmente constituído, ajuizou a presente "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, parte ré igualmente identificada.

Alegou a parte autora, em sua petição inicial, que:

A) foi diagnosticado a cerca de 10 anos com Transtorno Depressivo Recorrente grave (CID 10.F33.2), Transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e Fibromialgia (CID M79.7);

B) nos últimos 7 anos, o Autor deu início a uma piora gradativa ao demonstrar refratariedade as medicações utilizadas, apresentando também efeito paradoxal, isto é, efeitos contrários aos desejados/esperados;

C) enfrenta grande dificuldade para continuar realizando seu trabalho como agente de saúde, já que mesmo com o uso contínuo das medicações disponíveis no Brasil e no SUS se encontra frequentemente debilitado;

D) são frequentes no Autor sintomas como pensamentos negativos e autodestrutivos, embotamento afetivo, isolamento, angústia, Hipobulia, Hipotímico, dor persistente pelo corpo, medos incontroláveis e outros,

E) já utilizou diversas medicações e atualmente está em uso de Carbolitium, Clonazepan, Quetiapina, Olanzapina e Dimorf;

F) ocorre que o uso de tais medicamentos apresentou muitos efeitos colaterais como sedação, náuseas, tonturas, tremores, cefaleia, prurido, diarreia, palpitações, ansiedade, perda involuntária de urina, ataxia (dificuldade na coordenação motora), falta de ar, acne, xerostomia (boca seca), sede excessiva, distúrbio de visão, hiperidrose, alteração do paladar e do humor, má digestão, prisão de ventre, comprometimento da memória, instabilidade, cansaço excessivo, entre muitos outros;

G) em função do quadro descrito, foi indicado pelo médico assistente o uso do seguinte medicamento: PURE CANNABIDIOL FULL SPECTRUM – 1500mg/30ml (50mg/ml), na dosagem de 9 ml, ou 360 gotas a cada 12 horas;

H) a medicação não faz é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, mas o custo do tratamento está absolutamente fora da sua realidade financeira, tendo em vista que apenas dois frascos custam em média o equivalente à toda sua renda mensal.

Pugnou pela tutela antecipada para determinar que forneça o medicamento indicado por laudo médico.

Ao final, requereu a total procedência da demanda, condenação em obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos, no importe de R$ 24.000,00 e a condenação em indenização dos danos morais ocasionados e 37.537,45.

Atribuiu à causa o valor de R$ 61.537,45. Pugnou pela gratuidade da Justiça.

Na decisão de ID 132653703 foi deferida a gratuidade da Justiça e indeferido o pedido de tutela provisória.

A seguradora ré apresentou contestação (ID 139238603), onde argumentou que não há de obrigatoriedade de a Operadora fornecer medicamentos que não estão dentro das hipóteses legais. A medicação requerida pela parte autora é de uso domiciliar e não, desta feita, tem cobertura obrigatória, sendo decida a negativa de fornecimento. Requereu a total improcedência da demanda.

Réplica apresentada (ID 144069408).

Decisão de ID 166726102, declarou o fim da instrução processual.

Em ID 171448556, a parte autora comunicou a interposição de agravo.

Decisão do E. TJPE, reformou a decisão do Juízo, para determinar ao plano de saúde o custeio integral do tratamento do autor, conforme laudo médico de ID 132239134 (ID 171448557).

Voltaram-me os autos conclusos para julgamento.

É relatório necessário. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo comporta julgamento antecipado dos pedidos, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto versa sobre matéria de direito e de fato, mas que dispensa a produção de prova em audiência, dado que as provas trazidas aos autos já são suficientes para o julgamento da causa.
Por inexistirem preliminares ou prejudiciais, passo, de imediato, ao mérito da demanda.

DA APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/1998

Inicialmente, pontuo que, tratando-se de questão afeta à saúde, é aplicável a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Ressalto, ainda, Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça ao qual menciona que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins de compelir a empresa demanda a arcar os custos da medicação PURE CANNABIDIOL FULL SPECTRUM. É fato incontroverso que a autora padece da doença indicada na inicial, bem como os riscos a que se submete.

Cinge-se a lide, unicamente, em verificar a obrigatoriedade de cobertura da medicação requerida, bem como de eventual existência de danos morais.

Da análise atenta dos autos, verifico que não assiste razão à parte demandante.

Explico.

Sobre o direito material específico em questão, a Lei nº 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura das doenças listadas na “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde”.

É o que se conclui da leitura de seu artigo 10,capute §2º, que traz o chamado “plano-referência”, de cobertura mínima devida a qualquer beneficiário do plano.

> “Art. 10.É instituído oplano-referênciade assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar,compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> § 2ºAs pessoas jurídicasque comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Leioferecerão, obrigatoriamente, a partir de3 de dezembrode 1999, o plano-referência de que trata este artigoa todos os seusatuais efuturos consumidores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001 c/c ADI 1931, STF)”

O plano-referência, de oferta mínima obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, portanto, ressalvadas hipóteses dos incisos do artigo 10, abarca todos os tratamentos das doenças elencadas com CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Sendo assim, basta que a parte autora, vinculada ao plano de saúde, junte atestado de profissional da saúde habilitado a tanto demonstrando necessidade de tratamento de doença sofrida para que tenha direito à cobertura do tratamento.

Portanto, a doença da qual padece o beneficiário do plano de saúde e o respectivo tratamento devem ser atestadas por profissional competente para tanto, de livre escolha do paciente, o que é assegurado pela própria lei 9.656/98 (art. 1º, I) e pela RN 428/ANS (art. 5º).

Especificamente sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por parte da operadora de plano de saúde, o já mencionado artigo 10 da Lei nº 9.656/98 põe a salvo situações específicas em seus incisos em que a cobertura não é obrigatória por força de lei, sem prejuízo de sua previsão contratual.

É o caso, por exemplo, do custeio de alguns tipos de medicamentos, cujo fornecimento não é obrigatório, salvo em casos de doenças específicas, como o câncer, ou que necessitem de administração ambulatorial, sendo que os medicamentos para uso doméstico e os importados não nacionalizados não são abrangidos pelo plano de referência.

Desta feita, nos termos da Lei nº 9.656/98, percebe-se que o fornecimento de medicamentos é devido, desde que não se trate de medicamentos importados nacionalizados nem os de uso para tratamento domiciliar, e, ainda, são devidos aqueles fármacos previstos no disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12 da lei 9.656/98, que visem tratamentos de câncer.

Em tempo, segundo a Resolução Normativa nº 167 da ANS, a definição de medicamento domiciliar é: "medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência)".

No caso ora analisado, o medicamento cujo fornecimento foi pleiteado é de uso doméstico, foi juntado atestado médico confirmando que a autora possui doença, especificando a necessidade de tratamento mediante uso de medicamento, entretanto, a medicação é ministrada em seu domicílio.

Assim, é de fácil percepção que o medicamento requerido pela parte autora não está previsto como exceção dentre as hipóteses legais previstas, não sendo o caso de administração ambulatorial e hospitalar, ou de medicação para o câncer.

Trata-se, portanto, de medicamento para tratamento domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, pois foi prescrito pelo médico assistente para ser autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente domiciliar em substituição ao atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Desta feita, forçoso concluir pela ausência de cobertura legal para fornecimento deste medicamento.

Nesse sentido, veja-se:

> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. FÁRMACO DE AUTOADMINISTRAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Somatropina 15mg, prescrito para o tratamento da doença que acomete o beneficiário (baixa estatura idiopática). (...) Assim, reconhecida a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, passa-se a análise da questão relativa a obrigatoriedade de cobertura do medicamento pleiteado pelo beneficiário, qual seja, Somatropina 15mg. Segundo informa o laboratório detentor do registro do Norditropin (nome comercial da Somatropina) na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em "solução injetável de somatropina - 1 sistema de aplicação preenchido descartável multidose que contém um carpule de 1,5 mL, vedado permanentemente em um sistema de aplicação de plástico. O botão de aplicação do sistema possui cor de acordo com a concentração: 5 mg/1,5 mL (laranja)" (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000015299065/). Trata-se, portanto, de medicamento para tratamento domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, pois foi prescrito pelo médico assistente para ser auto administrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente domiciliar em substituição ao atendimento ambulatorial ou hospitalar. Nessa toada, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"(REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021). Logo, considerando que o fármaco requerido nos autos (Somatropina 15mg) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998, forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde, diversamente do que decidiu o TJ/CE. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, fica redistribuída a sucumbência, arcando a parte recorrida com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada eventual concessão da gratuidade de

justiça. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá? acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1959202 CE 2021/0288107-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/10/2021).

Sobre o caso específico de fornecimento do CANABIDIOL, trago se seguinte precedente, deste E. TJPE:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016456-45.2020.8.17.9000 ÓRGÃO JULGADOR: 4ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Rafael José de Menezes - 8ª Vara Cível da Capital - Seção B AGRAVANTE: Fátima de Lourdes Moscoso Ferreira Lima AGRAVADA: Sul América Companhia Seguro Saúde EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE.DOR CRÔNICA INCAPACITANTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. MEDICAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos do art. 10, VI, da lei 9.656/98, está excluído da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos. 2. A interpretação a ser conferida ao art. 10, VI, da lei 9.656/98, bem como à resolução 428/2017 da ANS,levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e à sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante -, é a de que a negativa de medicamentos domiciliares abrange tão somente os fármacos ordinários que não estejam intrinsecamente relacionados à manutenção da vida do paciente. Em outras palavras, não atinge os medicamentos necessários para a cura de doenças e comorbidades graves ou crônicas, que importem risco à própria vida do beneficiário. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 0016456-45.2020.8.17.9000, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - AI: 00164564520208179000, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 21/06/2021, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (Processos Vinculados - 4ª CC))

Em que pese nos solidarizarmos com a condição de saúde da parte autora e entender a necessidade de ver realizado o tratamento, não vislumbro a responsabilidade de a operadora de saúde arcar com os custos da medicação requestada.

Nesta ordem de ideias, a improcedência do pedido de custeio do tratamento é medida que se impõe e, considerando a inexistência de negativa indevida, de igual forma, deve ser improcedente o pleito indenizatório.

III - DISPOSITIVO

Desse modo, pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC **julgo totalmente improcedentes os pedidos**.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor dos pedidos. Fica a exigibilidade do pagamento do ônus da sucumbência suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da Justiça.

Expeça-se ofício para o TJPE, comunicando a prolatação da sentença.

Ademais, havendo interposição de apelação, em consonância com o art. 1.010 do CPC: (a) intime-se o recorrido para, no prazo de 15 dias, apresentar as devidas contrarrazões (§ 1º); (b) se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (§ 2º); (c) decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio TJPE, com as homenagens deste Juízo (§ 3º).

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Datado e assinado eletronicamente.

mmm

Assinado eletronicamente por: **BRENDA AZEVEDO PAES BARRETO TEIXEIRA**
10/01/2025 11:24:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **192183095**

25011011244968500000187357103

IMPRIMIR GERAR PDF